

ВИНЬЕТКИ

Делирий

Пять вызовов: гипоактивный, послеоперационный, алкогольный, антихолинергический и то, что делирием не является

Сначала все задачи, затем все решения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Тихая бабушка

Дом престарелых. Медсестра: «Сегодня какая-то не такая, всё время спит, на обед не вышла. Вчера была обычная.»

Женщина, 84 года. Болезнь Альцгеймера, лёгкая стадия. Обычно ходит сама, общается, ест самостоятельно.

Лежит в кровати, глаза закрыты. На голос открывает глаза, смотрит мимо, через пять секунд закрывает. На вопросы отвечает односложно и невпопад. Встать не пытается. ЧСС 92 в минуту, АД 100/65 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO₂ 93 %, температура 37,9 °С. Живот мягкий; при пальпации надлобковой области — слабая гримаса. Кожа сухая, тургор снижен. На тумбочке: донепезил, мемантин, амлодипин.

1. Какой тип делирия соответствует описанию? Какова оценка по шкале RASS?
2. Чем острое изменение поведения у пациента с деменцией отличается от самой деменции?
3. Какая причина делирия здесь наиболее вероятна и какие находки на неё указывают?
4. Как трактовать SpO₂ 93 % и что из этого следует для помощи?
5. Показана ли седация?
6. Объём помощи на месте и профиль стационара.

Случай 2. После протезирования

Хирургическое отделение, ночь. Мужчина, 79 лет. Двое суток назад — плановое протезирование тазобедренного сустава. До операции когнитивно сохранен. Гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа. Медсестра: пытается встать, выдернул мочевого катетер, кричит «Пожар! Всем выходить!»

Возбуждён, пытается выбраться из кровати. Глаза широко открыты, указывает в угол палаты: «Там дым!» ЧСС 105 в минуту, АД 165/95 мм рт. ст., ЧД 22 в минуту, SpO₂ 96 %, температура 37,2 °С. Зрачки симметричные, обычные. Повязка на бедре сухая. Последнее обезболивание — кеторолак 12 часов назад.

1. Тип делирия и оценка по RASS.
2. Не менее четырёх факторов риска делирия, уже имеющих у этого пациента.
3. Что с наибольшей вероятностью послужило триггером именно этой ночью?
4. Допустима ли физическая фиксация к кровати?
5. Какие немедикаментозные меры применяются первыми?
6. Если возбуждение сохраняется и есть риск падения на оперированное бедро — какой препарат и в какой дозе?

Случай 3. Соседи жалуются

Полиция вскрыла дверь. Мужчина, 52 года. Квартира разгромлена, пустые бутылки на полу. Соседи: три дня не выходит, крики и грохот; «три дня назад перестал выходить за водкой».

Сидит на полу в углу кухни, обхватив колени, крупноразмахистый тремор. При появлении бригады вскакивает: «Уберите их! Они по стенам ползут!» Пот, расширенные зрачки, кожа горячая и мокрая. ЧСС 128 в минуту, АД 175/105 мм рт. ст., ЧД 24 в минуту, SpO₂ 96 %, температура 38,9 °С.

1. Диагноз и его обоснование по срокам от последней выпивки.

2. Какие три группы признаков составляют клиническое ядро этого состояния?
3. Как трактовать температуру 38,9 °С и какой порог меняет прогноз?
4. Препарат первой линии, доза, путь, механизм выбора.
5. В какой последовательности вводятся тиамин и глюкоза и почему порядок фиксирован?
6. Показан ли галоперидол?
7. Профиль стационара.

Случай 4. Таблетка от зуда

Женщина, 71 год. Дочь два часа назад дала дифенгидрамин 50 мг от кожного зуда. «Стала странная.»

Сидит на диване, перебирает руками невидимые предметы, бормочет, дезориентирована. ЧСС 112 в минуту, АД 155/85 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO₂ 97 %, температура 37,4 °С. Зрачки расширены. Кожа сухая, горячая. Рот сухой. Живот мягкий, перистальтика ослаблена. На тумбочке: амитриптилин, дифенгидрамин, лоратадин.

1. Какой токсидром соответствует находкам? Какие признаки осмотра его собирают?
2. Какой медиатор блокирован и почему это даёт делирий?
3. Меняет ли картину хронический приём амитриптилина?
4. Показан ли галоперидол?
5. Чем купировать нарастающее возбуждение?
6. Существует ли специфический антидот и какие у него ограничения на догоспитальном этапе?

Случай 5. Не психиатрия?

Улица. Женщина около 35 лет, одета аккуратно, зимняя куртка расстёгнута, шапки нет. Ходит кругами, жестикулирует, говорит о голосах, которые «велят идти». На просьбу показать руки — показывает. Следов инъекций нет. ЧСС 78 в минуту, АД 120/75 мм рт. ст., ЧД 14 в минуту, SpO₂ 99 %, температура 36,6 °С. Зрачки обычные, симметричные. Кожа обычная. Очаговой неврологии нет. Запаха алкоголя нет. Галлюцинации слуховые.

1. Что больше соответствует описанию — делирий или психоз? По каким трём признакам?
2. Исключают ли стабильные витальные показатели органическую причину?
3. Какие две проверки обязательны при любом остром изменении психики?
4. Показана ли седация?
5. Куда доставлять?
6. В каком порядке решаются соматический и психиатрический маршруты?

Решения

Случай 1

1. Гипоактивный делирий. RASS –2: пробуждение на голос кратковременное, зрительный контакт короче десяти секунд. Именно гипоактивная форма пропускается чаще всего.
2. Деменция — хронический фон. Делирий — острое изменение относительно обычного состояния этого человека. Медсестра зафиксировала сдвиг за сутки: обычно ходит и ест, сегодня лежит и не реагирует. Любое острое ухудшение у пациента с деменцией расценивается как делирий, пока не доказано иное.
3. Инфекция мочевых путей на фоне дегидратации. Указывают субфебрилитет (у пожилых нередко единственный признак инфекции), болезненность над лоном, сухая кожа и сниженный тургор. У пожилых женщин это частая причина делирия.
4. SpO₂ 93 % — гипоксемия. Кислород до SpO₂ не ниже 94–95 %. Гипоксия сама поддерживает делирий.
5. Седация не показана. Угнетение сознания уже есть; седативное его углубит. «Тихий» не означает «стабильный».
6. Глюкометрия, венозный доступ, натрия хлорид 0,9 % при признаках дегидратации, кислород, парацетамол как антипиретик, мониторинг. Госпитализация в терапевтический стационар с указанием на возможный уросепсис. Реанимационный маршрут при этой гемодинамике не обязателен, но формулировка подозрения должна прозвучать при передаче.

Случай 2

1. Гиперактивный делирий. RASS +3: выраженное возбуждение, удаление катетера, крик.
2. Возраст 79 лет; недавняя операция и наркоз; сахарный диабет; иммобилизация после протезирования; мочевого катетер; смена обстановки; вероятное нарушение сна в палате.
3. Нелечёная боль (последний анальгетик 12 часов назад после эндопротезирования) в сочетании с ночным временем. Боль и дезориентация в темноте суммируются.
4. Фиксация не применяется как метод лечения делирия: усиливает страх и борьбу, даёт рабдомиолиз, травму, позиционную асфиксию и повышает летальность. Сначала устраняется причина (боль), затем немедикаментозные меры, при необходимости — фармакологическая седация.
5. Обезболивание (парацетамол внутривенно; кеторолак — если нет противопоказаний); ночник, а не полная темнота; повторная ориентация («больница, после операции, пожара нет»); присутствие близкого, если возможно.
6. Галоперидол 0,5–1 мг внутримышечно или внутривенно. Доза 5–10 мг у 79 лет избыточна. Повтор через 30 минут при отсутствии эффекта. Параллельно — обезболивание.

Случай 3

1. Алкогольный делирий (delirium tremens). Окно 48–96 часов от последней выпивки; здесь около трёх суток.

2. Спутанность с дезориентацией и зрительными галлюцинациями; крупноразмашистый тремор; вегетативная гиперактивность (тахикардия, артериальная гипертензия, потливость, гипертермия, мидриаз).
3. 38,9 °C — уже значимая гипертермия, ещё не край. Порог, меняющий прогноз, — температура выше 40 °C: летальность резко растёт. Нужны мониторинг и активное охлаждение.
4. Диазепам 10 мг внутривенно, повторять каждые 5–10 минут до контроля возбуждения. Алкоголь — агонист ГАМК-А; его отмена даёт дефицит торможения. Диазепам занимает тот же рецептор (перекрёстная толерантность) и лечит механизм, а не только поведение.
5. Тиамин 100 мг внутривенно до глюкозы. У хронического алкоголика запас тиамина истощён; глюкоза без тиамина расходует остаток на окисление углеводов и может спровоцировать энцефалопатию Вернике.
6. Галоперидол не показан. Снижает судорожный порог в окне абстиненции. Препараты выбора — бензодиазепины.
7. Реанимация. Нелечёный алкогольный делирий имеет летальность порядка 15–20 %.

Случай 4

1. Антихолинергический токсидром. Собирают: мидриаз; сухая горячая кожа; сухость слизистых; тахикардия; ослабленная перистальтика; зрительные галлюцинации (перебирание невидимых предметов); спутанность.
2. Заблокирован мускариновый эффект ацетилхолина. Дифенгидрамин — антигистаминный препарат с выраженным антихолинергическим действием. Снижение холинергической передачи в коре даёт делирий напрямую.
3. Амитриптилин сам обладает сильным антихолинергическим действием. Хронический приём снижает исходный резерв ацетилхолина; дифенгидрамин добавляет вторую нагрузку. Это антихолинергическая полипрагмазия: каждый препарат по отдельности может переноситься, сумма даёт токсидром.
4. Галоперидол не показан: собственный антихолинергический компонент, риск удлинения QT и нейролептического злокачественного синдрома.
5. Бензодиазепин без антихолинергического действия: диазепам 5–10 мг внутривенно или мидазолам 5 мг внутримышечно.
6. Физостигмин существует и повышает ацетилхолин, ингибируя ацетилхолинэстеразу. На догоспитальном этапе обычно недоступен. Даже в стационаре он противопоказан при широком QRS, судорогах и при подозрении на отравление трициклическим антидепрессантом: на фоне блокады натриевых каналов вагусный эффект даёт асистолию. У этой пациентки на тумбочке амитриптилин — физостигмин не рассматривается.

Случай 5

1. Ближе психоз, чем делирий. В пользу психоза: слуховые галлюцинации (при делирии чаще зрительные); выполнение инструкции и ответы на вопросы — сознание относительно ясное; стабильные витальные показатели и нормальные зрачки, то есть нет токсидрома и грубой соматики.
2. Нет. Гипонатриемия, объёмное образование, ранний менингит, гипотиреоз и ряд интоксикаций могут давать психотическую картину при ещё спокойных цифрах на мониторе.

3. Глюкоза капиллярной крови. Температура (здесь уже измерена). Дополнительно — осмотр головы, следов инъекций, запахов и расспрос о психиатрическом анамнезе и препаратах.
4. Седация не показана: агрессии и непосредственной угрозы нет, контакт есть.
5. Психиатрический стационар — после того, как на месте исключены гипогликемия, лихорадка, очаговая неврология и очевидная травма.
6. Сначала соматика, потом психиатрия.

Основные выводы

№	Вывод
1	Гипоактивный делирий пропускают. Острое изменение у пациента с деменцией — делирий, пока не доказано иное.
2	Нелечёная боль запускает послеоперационный делирий. Фиксация не лечит. Галоперидол у пожилого — 0,5–1 мг.
3	Алкогольный делирий лечат бензодиазепином. Галоперидол снижает судорожный порог. Тиамин раньше глюкозы.
4	Антихолинергическая полипрагмазия. Галоперидол и физостигмин на фоне трициклического антидепрессанта не применяются.
5	Слуховые галлюцинации при ясном сознании ближе к психозу. Маршрут всё равно начинается с соматики.